



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY KOMPREHENSIF)
24 JAM**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan PONEK
Tahun 2025

Disusun oleh:
Ketua PONEK



(dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp. OG)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., Cl., CHAE., CHQP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan PONEK Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan PONEK di Rumah Sakit ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan PONEK Rumah Sakit mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY
KOMPREHENSIF) 24 JAM

PENGARAH

Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.,CCHt.,CI.,CHAE.,CHQP

PENYUSUN

1. dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG
2. dr. Harli Noviar Kagendra., Sp.An
3. dr. Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed
4. dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A
5. dr. Fina Jazirah
6. Ninis Indrawati, S.Tr.Keb
7. Jihan Ananiah SSD, STr.Keb
8. Aulia Rahma, Amd.Keb
9. Debi Firmanasia, Amd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 TUJUAN DAN FUNGSI PEDOMAN PELAYANAN PONEK 24 JAM	6
1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN	6
1.4 PENGERTIAN DAN BATAS OPERASIONAL	6
BAB II STANDAR KETENAGAAN	7
2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA	7
2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN	7
2.3 PENGATURAN JAGA	8
BAB III STANDAR FASILITAS	9
3.1 DENAH RUANG	9
3.2 STANDAR FASILITAS PONEK	15
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN TATA LAKSANA	17
4.1 KRITERIA PELAYANAN PONEK 17	
4.2 MEKANISME ALUR PELAYANAN PONEK	17
4.3 PELAYANAN RAWAT JALAN	18
4.4 PELAYANAN RAWAT INAP	19
4.5 KLASIFIKASI PENYAKIT	19
4.6 SITEM RUJUKAN	20
BAB V PENERAPAN PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	22
5.1 PENGERTIAN	22
5.2 TUJUAN	22
5.3 SASARAN	22
5.4 STRATEGI PELAKSANAAN	22
BAB VI LOGISTIK.....	24
6.1 SARANA DAN PRASARANA	24
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	26
7.1 PENGERTIAN	26
7.2 TUJUAN	26
7.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN	26
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	27
8.1 PENGERTIAN	27
8.2 TUJUAN	27
8.3 TATA LAKSANA	27
BAB IX	
PENGENDALIAN MUTU	28
BAB VIII	
PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	30

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 738.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**TENTANG PEDOMAN PELAYAAAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu di Rumah Sakit Prima Husada, maka perlu adanya kebijakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya Kebijakan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) Rumah Sakit Prima Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Kebijakan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif).
- Mengingat** : a. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit;
- g. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- h. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
- i. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PONEK (PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF) 24 JAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Pelayanan PONEK 24 jam adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif 24 jam;
- (2) Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam;
- (3) Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier;
- (4) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Adalah pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang diselenggarakan di rumah sakit secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan selama 24 jam untuk menangani kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- (5) Tim PONEK Rumah Sakit Adalah tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter anestesi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal selama 24 jam;
- (6) Standar Pelayanan PONEK adalah pedoman teknis yang digunakan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara aman, bermutu, efektif, dan sesuai standar profesi serta peraturan perundang-undangan;
- (7) Rujukan Maternal dan Neonatal Adalah proses pengalihan pasien ibu dan/atau bayi baru lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau jejaring ke rumah sakit PONEK untuk mendapatkan pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan medis;
- (8) Audit Maternal Perinatal (AMP) Adalah proses kajian sistematis terhadap kematian ibu dan bayi atau kasus morbiditas berat untuk mengidentifikasi penyebab, faktor risiko, serta upaya perbaikan pelayanan kesehatan.



BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2 Pengorganisasian

- (1) Pelayanan PONEK dilaksanakan oleh Tim PONEK Rumah Sakit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.;
- (2) Tim Ponek bekerja sesuai dengan uraian tugas dan wewenang masing-masing;
- (3) Tim PONEK berada di bawah koordinasi Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- (4) Tim PONEK terdiri atas tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;
- (5) Struktur organisasi Tim Ponek terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua tim PONEK
 - c. Sekretaris;
 - d. Dokter Spesialis anak;
 - e. Dokter Spesialis Anastesi;
 - f. Dokter Umum IGD;
 - g. Bidan ruang Bersalin;
 - h. Bidan ruang Bersali;
 - i. Perawat ruang Neonatus;
 - j. Bidan Poli Klinik kebidanan;
 - k. Bidan IGD;
 - l. Perawat Intensif Care Unit (ICU).

BAB III STANDART FASILITAS

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menyediakan fasilitas pelayanan PONEK yang siap digunakan 24 jam;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang mampu melakukan stabilisasi kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - b. Ruang bersalin yang siap tindakan emergensi;
 - c. Kamar operasi yang siap 24 jam untuk tindakan seksio sesarea emergensi;
 - d. Ruang pemulihan (recovery room) yang berfungsi optimal;
 - e. Ruang perawatan maternal dan neonatal.
- (3) Rumah sakit menyediakan obat emergensi obstetri dan neonatal secara lengkap;
- (4) Rumah sakit menyediakan layanan penunjang 24 jam meliputi:
 - a. Laboratorium;
 - b. Radiologi;
 - c. Bank darah atau akses darah cepat;



d. Farmasi emergensi.

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kemampuan pelayanan, RS PONEK Spesialistik memiliki kemampuan pelayanan paling sedikit meliputi:
 - a. Pelayanan Maternal, paling sedikit meliputi:
 - 1) Hipertensi (TD > 140/90 mmHg);
 - 2) Preeklamsia tanpa keterlibatan organ;
 - 3) Anemia (Hb < 11 g/dl);
 - 4) Infeksi;
 - 5) Riwayat permasalahan obstetrik (operasi rahim, gagal hamil);
 - 6) Perdarahan antepartum;
 - 7) Perdarahan postpartum;
 - 8) Kelainan plasenta (plasenta previa non akreta, solusio plasenta tanpa komplikasi);
 - 9) Kelainan tali pusat (prolaps);
 - 10) Ketuban pecah dini;
 - 11) Kelainan air ketuban (polihidramnion, oligohidramnion, anhidramnion);
 - 12) Kelainan usia kehamilan (preterm, postterm);
 - 13) Kelainan jumlah janin (2/gemeli);
 - 14) Kelainan letak janin (lintang, oblik, sungsang, malpresentasi);
 - 15) Kelainan ukuran janin (pertumbuhan janin terhambat, makrosomia, kematian janin intra uterin);
 - 16) Disproporsi kepala panggul; dan
 - 17) Gawat janin;
 - b. Pelayanan Neonatal paling sedikit meliputi :
 - 1) Persalinan seksio sesarea dengan berat bayi > 1.800 gram atau usia kehamilan > 34 minggu
 - 2) Bantuan nafas noninvasif atau invasif sesuai pasien;
- (2) Sumber daya manuksi kesehatan, RS PONEK Spesialis harus memiliki sumber daya manusia kesehatan dalam bentuk tim PONEK, meliputi :
 - a. dengan kompetensi di kegawatdaruratan maternal dan neonatal; bidang tatalaksana;
 - b. Dokter dengan kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi;
 - c. Dokter dengan kompetensi di bidang kesehatan anak dengan pelatihan resusitasi dan stabilisasi neonatal;
 - d. Dokter dengan kompetensi di bidang anesthesiologi dan terapi intensif;
 - e. Bidan;
 - f. yang terlatih kegawatdaruratan maternal.



BAB V
TATALAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari untuk menjamin ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara berkesinambungan;
- (2) Pelayanan PONEK dilakukan secara cepat, tepat, aman, efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- (3) Tatalaksana pelayanan PONEK dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, pedoman praktik klinis, dan prosedur operasional standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelayanan maternal meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, dan penanganan komplikasi maternal;
- (2) Pelayanan ibu nifas meliputi pemantauan kondisi ibu, deteksi dini komplikasi, pemberian edukasi, dan perencanaan tindak lanjut pelayanan;
- (3) Setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar yang berlaku;
- (4) Bayi baru lahir dengan kondisi gawat darurat harus segera mendapatkan tindakan resusitasi dan stabilisasi;
- (5) Pelayanan neonatal meliputi pemantauan tanda vital, pemberian terapi, pemeriksaan penunjang, dan perawatan sesuai kondisi klinis bayi.

BAB VI
RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

Pasal 7

- (1) Rumah sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah Rumah sakit pemerintah maupun swasta, umum dan khusus yang telah melaksanakan 10 langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna;
- (2) Rumah sakit wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara terpadu dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- (3) Rumah sakit melaksanakan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu

BAB VII
LOGISTIK

Pasal 8

- 1) Logistik Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif



(PONEK) merupakan seluruh sarana, prasarana, peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), darah dan produk darah, serta kebutuhan penunjang lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan PONEK. Terdapat laporan tentang monitoring dan evaluasi secara rutin program PONEK;

- 2) Pengelolaan logistik PONEK dilaksanakan sesuai dengan kebijakan rumah sakit, standar pelayanan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan logistik PONEK dilakukan secara berkala berdasarkan:
 - a. Data kunjungan pasien dan angka persalinan;
 - b. Pola penyakit dan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - c. Pemakaian logistik periode sebelumnya;
 - d. Standar kebutuhan pelayanan PONEK.
- (2) Tim PONEK berkoordinasi dengan unit terkait dalam menyusun kebutuhan logistik tahunan maupun kebutuhan insidental.

Pasal 10

- (1) Rumah sakit wajib menjamin ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, BMHP, darah dan produk darah yang diperlukan dalam pelayanan PONEK.

BAB VIII KESELAMATAN PASIEN

Pasal 11

- (1) Keselamatan pasien dalam pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan prioritas utama dalam setiap proses pelayanan maternal dan neonatal;
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan PONEK wajib menerapkan budaya keselamatan pasien sesuai dengan kebijakan dan peraturan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Pelayanan PONEK wajib menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang meliputi:
 - a. Ketepatan identifikasi pasien;
 - b. Peningkatan komunikasi yang efektif;
 - c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;
 - d. Kepastian tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat lokasi tindakan;
 - e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan;
 - f. Pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh.
- (2) Sasaran keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh pelayanan maternal dan neonatal.

BAB IX KESELAMATAN KERJA

Pasal 13

- (1) Keselamatan pasien dalam pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan prioritas utama dalam setiap



- proses pelayanan maternal dan neonatal;
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan PONEK wajib menerapkan budaya keselamatan pasien sesuai dengan kebijakan dan peraturan rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Pelayanan PONEK wajib menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang meliputi:
- Ketepatan identifikasi pasien;
 - Peningkatan komunikasi yang efektif;
 - Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;
 - Kepastian tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat lokasi tindakan;
 - Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
 - Pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh;
- (2) Sasaran keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh pelayanan maternal dan neonatal;

BAB X PENGENDALIAN MUTU

Pasal 15

- (1) Pengendalian mutu pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) merupakan serangkaian kegiatan sistematis untuk memastikan pelayanan maternal dan neonatal berjalan sesuai standar, aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- (2) Pengendalian mutu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.
- (3) Pengendalian mutu bertujuan untuk:
- Meningkatkan mutu pelayanan PONEK secara berkelanjutan;
 - Menurunkan angka kematian ibu dan neonatal;
 - Mengurangi kejadian yang tidak diharapkan dalam pelayanan maternal dan neonatal;
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, standar profesi, dan prosedur operasional baku;
 - Meningkatkan keselamatan pasien dalam pelayanan PONEK.
- (4) Tim PONEK wajib melakukan kegiatan pengendalian mutu secara berkesinambungan melalui:
- Monitoring indikator mutu;
 - Audit klinis;
 - Audi maternal perinatal;
 - Analisis insiden keselamatan pasien;
 - Supervisi pelayanan;
 - Evaluasi kinerja pelayanan PONEK.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif



- (PONEK) ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan maternal dan neonatal di Rumah Sakit secara terpadu, terstandar, dan berkesinambungan;
- (2) Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Revisi pedoman dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi mutu pelayanan, audit maternal perinatal, hasil monitoring indikator, serta temuan insiden keselamatan pasien;
- (2) Setiap perubahan dan/atau revisi pedoman harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal, 1 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.K



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

NOMOR : 738.1/RSPHS/I/PER/DIR/XI/2025
TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI KOMPREHENSIF)

PEDOMAN PELAYANAN PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF) 24 JAM DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Sebagian besar kematian ibu dan bayi terjadi akibat komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan komprehensif.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, aman, efektif, dan berkesinambungan diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) selama 24 jam setiap hari.

Penyelenggaraan PONEK bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pelayanan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia kompeten, sarana prasarana yang memadai, sistem rujukan yang efektif, serta jejaring pelayanan kesehatan yang kuat. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dan unit terkait dalam melaksanakan pelayanan PONEK di rumah sakit secara terstandar. Pedoman PONEK terbaru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 yang menggantikan Kepmenkes Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008.

Rumah sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia perlu dilakukan pembekalan melalui standarisasi pelayanan yang ditetapkan di Rumah Sakit melalui pembuatan pedoman. Pedoman pelayanan PONEK ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada Sukorejo yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional



1.2 TUJUAN DAN FUNGSI PEDOMAN PELAYANAN PONEK 24 JAM

1.1.1 Tujuan Umum

Terciptanya system pelayanan PONEK 24 jam yang bermutu dan paripurna sebagai Sebagian dari pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

1.1.2 Tujuan Khusus

- Menyelenggarakan Asuhan kebidanan terstandar pada pelayanan PONEK 24 jam
- Menyelenggarakan Asuhan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling Asuhan sayang ibu dan bayi

1.1.3 Fungsi pelayanan Ponek 24 jam

- Terbentuk Tim PONEK Rumah Sakit
- Tercapainya kemampuan teknis Tim PONEK sesuai Standart
- Meningkatkan kualitas Pelayanan Maternal dan Perinatal yang bermutu dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia.
- Terlaksananya manajemen pelayanan maternal dan perinatal dari aspek administrasi & manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan di RS
- Terlaksananya system rujukan pelayanan maternal dan perinatal
- Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan akreditasi

1.2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

- Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif.
- Penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK Rumah Sakit di ruang tindakan.
- Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan section caesaria.
- Perawatan intensif ibu dan bayi.
- Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko Tinggi.

1.3 PENGERTIAN DAN BATASAN OPERASIONAL

- PONEK merupakan singkatan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
- Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.
- Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier.
- Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, umum dan khusus yang telah melaksanakan 10 Langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.



BAB II STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan KEPMENKES RI No : HK.01.07 /MENKES/560/2025 dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit tahun 2025, maka standar tenaga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1 Kualifikasi Sumber Daya Manuasia.

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
1.	Ketua Tim PONEK	Dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	S1 Kedokteran	1
2.	Sekretaris	Perawat/Bidan	DIV/S1 Kebidanan	1
3.	Anggota	Dokter spesialis anestesi	S1 Kedokteran	1
		Dokter Spesialis Anak	S1 Kedokteran	1
		Pendidikan dokter umum	S1 Kedokteran	2
		Bidan PONEK IGD	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
		Bidan Ruang bersalin dan Nifas	DIII/DIV/S1 Kebidanan	2
		Perawat ruang neonatus	DIII/DIV/S1/Kebidanan/keperawatan	1
		Perawat/Bidan Ruang Operasi	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
		Bidan ICU	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
		Bidan Poli Obgyn	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
		Total		13

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN.

Pelayanan PONEK dipimpin oleh dokter dan staf yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan yang berkualitas untuk menjamin dilaksanakannya pelayanan yang telah ditentukan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua Tim PONEK adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang terlatih
2. Koordinator IGD adalah dokter umum yang bertugas di IGD
3. Bidan PONEK adalah bidan yang bertugas di IGD PONEK
4. Koordinator Poli kebidanan adalah lulusan DIII Kebidanan, masa kerja minimal 3 tahun
5. Koordinator pelayanan ruang bersalin dan nifas adalah lulusan DIII Kebidanan, masa kerja minimal 3 tahun.
6. Koordinator Pelayanan Perinatologi adalah lulusan DIII Kebidanan atau keperawatan masa kerja 3 tahun

2.3 PENGATURAN JAGA / DINAS.

Jam dinas Tim Ponek :

Tabel 2. Pengaturan Jaga / Dinas. Jan Dinas Tim Ponek

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Dokter spesialis kebidanan dan kandungan	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	2 Orang
2	Dokter spesialis anak	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	3 orang
3	Dokter Spesialis Anestesi	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	2 Orang
4	Dokter UMUM	3 shif	24 jam	8 Orang
5	Bidan & Perawat	3 shif	Jam 06.30-14.30	6 orang
			Jam 14.00-21.00	6 Orang
			Jam 21.00-07.00	5 Orang



BAB III STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANG.

Ada pada lampiran

3.2 STANDAR FASILITAS PONEK.

Standart Fasilitas PONEK Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan PONEK antara lain :

1. Kriteria Umum Rumah Sakit PONEK.

- a) Ada dokter jaga yang terlatih di IGD untuk mengatasi kasus emergency baik secara umum maupun emergency obstetrik neonatus.
- b) Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- c) Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- d) Pedoman tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- e) Mempunyai standar respon time di IGD selama 10 menit, di kamar bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam.
- f) Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergency obstetrik atau umum.
- g) Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.
- h) Memiliki kru/petugas yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun *on call*.
- i) Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat.
- j) Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.
- k) Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti laboratorium dan radiologi selama 24 jam, recovery room 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia.
- l) Perlengkapan
 1. semua perlengkapan harus bersih (bebas, debu, kotoran, bercak, cairan dll)
 2. permukaan metal harus bebas karat atau bercak
 3. semua perlengkapan harus kokoh (tidak ada bagian yang longgar atau tidak stabil)
 4. permukaan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan besar
 5. roda perlengkapan (jika ada) harus lengkap dan berfungsi baik
 6. instrumen yang siap digunakan harus disterilisasi
 7. semua perlengkapan listrik harus berfungsi baik (saklar, kabel dan steker menempel kokoh)

2. Kriteria Khusus

a) Prasarana dan sarana.



Dalam rangka Program Menjaga Mutu pada penyelenggaraan PONEK diperlukan :

1. Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman
2. Ruang tindakan gawat darurat dengan instrumen dan bahan yang lengkap.
 - Ruang pulih/observasi pasca tindakan.
 - Protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi internal

b) Kriteria umum ruangan :

1. Struktur Fisik
 - d. Lantai dari porselin atau plastik
 - e. Dinding di cat dengan bahan yang bisa dicuci
2. Kebersihan
 - a. Cat dan lantai berwarna terang sehingga kotoran dapat terlihat dengan mudah.
 - b. Ruang bersih dan bebas debu, kotoran, sampah atau limbah rumah sakit.
 - c. Hal tersebut berlaku pula untuk lantai, mebel, perlengkapan, instrumen, pintu, jendela, dinding, steker listrik dan langit-langit.
3. Pencahayaan
 - a. Pencahayaan terang dari cahaya alami atau listrik.
 - b. Semua jendela diberi kawat nyamuk agar serangga tidak masuk.
 - c. Listrik berfungsi baik, kabel dan steker tidak membahayakan dan semua lampu berfungsi baik dan kokoh.
 - d. Tersedia peralatan gawat darurat.
 - e. Ada cukup lampu untuk setiap neonatus
4. Ventilasi
 - a. Ventilasi, termasuk jendela cukup jika dibandingkan dengan ukuran ruang.
 - b. Kipas angin atau pendingin ruang harus berfungsi baik.
 - c. Suhu ruangan harus dijaga 24-26°C.
 - d. Pendingin ruang harus dilengkapi filter (sebaiknya anti bakteri).
5. Pencucian tangan
 - a. Wastafel dilengkapi dengan sabun cair atau desinfektan
 - b. Wastafel, kran dan dispenser harus dipasang pada ketinggian yang sesuai (dari lantai dan dinding).
 - c. Tidak boleh ada saluran pembuangan air yang terbuka.

c) Kriteria khusus ruangan

1. Area cuci tangan di ruang obstetrik dan neonatus
2. Area resusitasi dan stabilisasi di Ruang Obstetri dan Neonatus/ IGD
 - a) Kamar PONEK di unit gawat darurat harus terpisah dari kamar gawat darurat lain. Sifat privasi ini penting untuk kebutuhan ibu bersalin dan bayi.
 - b) Tujuan kamar ini ialah: memberikan pelayanan darurat untuk stabilisasi kondisi pasien, misalnya syok, henti jantung, hipotermi, asfiksia dan apabila perlu menolong darurat serta resusitasi dilengkapi dengan meja resusitasi bayi, dan inkubator



c) Kamar PONEK membutuhkan :

1. Lemari dan troli darurat
2. Tempat tidur bersalin serta tiang infus
3. ~~Incubator transport~~
4. Meja, kursi
5. Alisan udara bersih dan sejuk
6. Pencahayaan
7. Lampu sorot dan lampu darurat
8. Oksigen dan tabungnya atau berasal dari sumber dinding
9. Lemari isi : perlengkapan persalinan, vakum, forceps, kuret, obat/infus
10. Alat resusitasi dewasa dan bayi
11. Wastafel dengan air mengalir dan antiseptic
12. Alat komunikasi dan telepon ke kamar bersalin
13. Nurse station dan lemari rekam medik
14. USG mobile
15. Sarana pendukung, meliputi : toilet, kamar tunggu keluarga, kamar persiapan peralatan (linen dan instrument), kamar kerja kotor, kamar jaga, ruang sterilisator dan jalur ke ruang bersalin/kamar operasi terletak saling berdekatan dan merupakan bagian dari unit gawat darurat.

d) Ruang Maternal.

1. Kamar Bersalin.

- Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD
- Luas minimal : 6 m² per orang. Berarti bagi 1 pasien, 1 penunggu dan 2 penolong diperlukan 4x4m²=16 m².
- Paling kecil, ruangan berukuran 12 m² (6 m² untuk masing-masing pasien).
- Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah.
- Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir.
- Ruang bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang.
- Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, upayakan tidak ada keharusan melintas pada ruang bersalin.
- Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit umum.
- Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan kamar neonatal, untuk memudahkan transport bayi dengan komplikasi ke ruang rawat.
- Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan unit terintegrasi : kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2.
- Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat (nurse station agar memudahkan pengawasan ketat setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin.
- Harus ada kamar mandi-toilet berhubungan kamar bersalin
- Ruang post partum harus cukup luas,
- Ruang tersebut terpisah dari fasilitas : toilet, kloset,



- lemari.
 - Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar tempat tidur minimum 1 m s.d 2 m dan antara dinding 1 m.
 - Jumlah tempat tidur per ruangan maksimal 4.
 - Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya dan udara cukup.
 - Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan.
 - Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi (tanpa ke koridor)
 - Ruang perawat (nurse station) berisi meja, telepon, lemari berisi perlengkapan darurat atau obat
2. Pojok Laktasi
Terdapat ruangan yang berisi meja, kursi, wastafel.
3. Ruang Operasi
- Instalasi kamar operasi diperlukan untuk tindakan operasi seksio sesaria dan laparotomi.
 - Disediakan unit komunikasi dengan kamar bersalin. Di dalam kamar operasi tersedia: pemancar panas dan perlengkapan resusitasi dewasa dan bayi.
 - Kamar pulih ialah ruangan bagi pasien pasca bedah berisi: meja, kursi, perawat, lemari obat, mesin pemantau tensi/nadi oksigen, tempat rekam medic, troli darurat.
 - Pengawasan langsung dari meja perawat ke tempat pasien.
 - Fasilitas pelayanan untuk unit operasi :
 1. Nurse station yang juga berfungsi sebagai tempat pengawas lalu lintas orang.
 2. Ruang kerja kotor yang terpisah dari ruang kerjabersih ruang ini berfungsi membereskan alat dan kain kotor, tempat cuci wastafel besar untuk cuci tangan dan fasilitas air panas atau dingin, ada meja kerja dan kursi kursi, troli.
 3. Saluran pembuangan kotoran atau cairan.
 4. Ruang tunggu keluarga
 5. Kamar sterilisasi yang berhubungan dengan kamar operasi. Ada autoklaf besar berguna bila darurat.
 6. Kamar obat berisi lemari dan meja untuk distribusi obat.
 7. Ruang cuci tangan (scrub) sekurangnyanya untuk 2 orang terdapat di depan kamar operasi atau kamar bersalin. Wastafel itu dirancang agar tidak membuat basah lantai. Air cuci tangan haruslah steril.
 8. Ruang kerja bersih .Ruang ini berisi meja dan lemari berisi linen, baju dan perlengkapan operasi. Juga terdapat troli pembawa linen.
 9. Kamar ganti
4. Ruangan Penunjang:
- a. Ruang perawat/bidan
 - b. Kantor perawat
 - c. Ruang rekam medic
 - d. Toilet staf
 - e. Ruang staf medic
 - f. Ruang loker staf/perawat
 - g. Ruang rapat/konferensi
 - h. Ruang keluarga pasien
 - i. Ruang cuci
 - j. Ruang persiapan diperlukan bila ada kegiatan persiapan alat/bahan

- k. Gudang peralatan
 - l. Ruang linen bersih
 - m. Laboratorium 24 jam
 - n. Radiologi dan USG
5. Peralatan Esensial

Tabel 3 Peralatan Maternal Esensial

[illegible]



		Suction Catheter No.6	1
		Suction Catheter No.8	1
		Slang perfusor	1
		Masker	
		Obat-obatan :	
		Atropin sulfat	2
		1 ml	1
		Dexametason	1
		1 ml	
		Dobutamin 5	1
		ml Dopamin	1
		10 ml	1
		Epinefrin 1 ml	1
		Infus D5 ½	1
		NS Infus D5	1
		1/4 NS Infus	1
		HES Lidokain	3
		2% 2 ml	1
		Natrium phenytoin 2 ml	1
		Phenobarbital 1 ml	1
		Stesolid rectal	
3	Set HPP	IV Canul 18	2
		IV Canul 20	2
		Iv cannul 22	2
		Folley cath 14	1
		Urine bag	1
		Kondom fiesta	1
		Sput 10 cc Terumo	1
		Sput 3 cc Terumo	1
		Film dressing	1
		Blood set	1
		Hy oxy dewasa	1
		Oxyflow dewasa	1
		Handscoon steril 6,5	1
		Handscoon steril 7	
		Asam tranexamat	2
		Misoprostol	3
		WI 1000 ml	1
		WI 25 MI	1
4	PEB SET	WI 25 ML	4
		MgSo4 20%	2
		MgSo4 40%	2
		Folley cath 16	1
		Sput 10cc Terumo	2
		Sput 20 cc Terumo	1
		Urine bag	1
		Oxyflow dewasa	1
		Hy oxy dewasa	1
		Handscoon steril no 7	1



5	Incubator	6
6	Infant warmer	4
7	Forceps naegele	1
8	Monitor denyut jantung/pernapasan (NST)	3
9	Fetal dopler	2
10	AVM (Aspirasi Vakum Manual)	2
11	Cuvis	3
12	Set Sectio Saesaria	4
13	USG Transport	1

Tabel 4. Peralatan Neonatal Esensial pada perawatan Neonatal NICU

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Inkubator	6
2	Infant Warmer : 1 (satu) di Instalasi IGD 1 (satu) unit di Kamar Bersalin 1 (satu) di instalasi kamar operasi 1 (satu) di perinatology	4
3	Pulse Oxymeter Neonatus	4
4	Therapy Sinar	1
5	Syringe Pump	5
6	Infus Pump	5
7	Tabung Oksigen	2
8	Lampu Tindakan	4
9	Alat-Alat Resusitasi Neonatus Laryngoskop Neonatal, Tong spatel Ambu Bag	1 1
10	CPAP (<i>Continous Positive Airways Preassure</i>)	4
11	Incubator Transport	1
12	Box bayi	16

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Inkubator	6
2	Infant Warmer : 1 (satu) di Instalasi IGD 1 (satu) unit di Kamar Bersalin 1 (satu) di instalasi kamar operasi 1 (satu) di perinatology	4
3	Pulse Oxymeter Neonatus	4
4	Therapy Sinar	1
5	Syringe Pump	5
6	Infus Pump	5
7	Tabung Oksigen	2
8	Lampu Tindakan	4
9	Alat-Alat Resusitasi Neonatus Laryngoskop Neonatal, Tong spatel Ambu Bag	1 1
10	CPAP (<i>Continous Positive Airways Preassure</i>)	4
11	Incubator Transport	1
12	Box bayi	16

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pengertian Pelayanan PONEK 24 Jam

Pelayanan PONEK 24 Jam adalah pemberian pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

4.2 Pengertian Rumah Sakit Pelayanan PONEK 24 Jam

Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

Rumah Sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal. Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien.

4.3 Pengertian Rujukan

1. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier.
2. Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:
 - a. Rujukan Pasien
Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit. Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada
 - b. Rujukan Manajemen
Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.

4.4 Kemampuan Pelayanan PONEK Rumah Sakit Kelas C

1. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis
 - Pelayanan Kehamilan
 - Pelayanan Persalinan
 - Pelayanan Nifas
 - Asuhan Bayi Baru Lahir (Level 1)
 - Immunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - Pelayanan Rawat Gabung ibu dan Bayi
 - Pemberian ASI Eksklusif
 - Pelayanan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR



2. Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi
 - a. Masa antenatal
 - Perdarahan pada kehamilan muda
 - Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut
 - Gerak janin tidak dirasakan
 - Demam dalam kehamilan dan persalinan
 - Kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
 - Kehamilan dengan Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan/koma, tekanan darah tinggi
 - b. Masa Intranatal
 - Persalinan dengan parut uterus
 - Persalinan dengan distensi uterus
 - Gawat janin dalam persalinan
 - Pelayanan terhadap syok
 - Ketuban pecah dini
 - Persalinan lama
 - Induksi dan akselerasi persalinan
 - Aspirasi vakum manual
 - Ekstraksi Cunam
 - Seksio sesarea
 - Epiotomi
 - Kraniotomi dan kraniosentesis
 - Malpresentasi dan malposisi
 - Distosia bahu
 - Prolapsus tali pusat
 - Plasenta manual
 - Perbaikan robekan serviks
 - Perbaikan robekan vagina dan perineum
 - Perbaikan robekan dinding uterus
 - Reposisi Inersio Uteri
 - Histerektomi
 - Sukar bernapas
 - Kompresi bimanual dan aorta
 - Dilatasi dan kuretase
 - Ligase arteri uterine
 - Bayi baru lahir dengan asfiksia
 - BBLR
 - Resusitasi bayi baru lahir
 - Anestesia umum dan lokal untuk seksio sesaria
 - Anestesia spinal, ketamine
 - Blok paraservikal/Blok pudendal (bila memerlukan pemeriksaan spesialisik, dirujuk ke RSIA/ RSU)
 - c. Masa Post Natal
 - Masa nifas
 - Demam pasca persalinan
 - Perdarahan pasca persalinan



- Nyeri perut pasca persalinan
 - Keluarga berencana
 - Asuhan bayi baru lahir sakit (level 2)
3. Pelayanan Kesehatan Neonatal
- hiperbilirubinemi,
 - Asfiksia
 - Trauma kelahiran,
 - Hipoglikemi
 - kejang,
 - sepsis neonatal
 - gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit gangguan pernapasan,
 - kelainan jantung (payah jantung, payah jantung bawaan,PDA),
 - gangguan pendarahan,
 - renjatan (shock),
 - aspirasi meconium
 - koma
 - Inisiasi dini ASI (Breast Feeding),
 - Kangaroo Mother Care,
 - Resusitasi Neonatus,
 - Penyakit Membran Hyalin
 - Pemberian minum pada bayi risiko tinggi
4. Pelayanan Ginekologis
- Kehamilan ektopik
 - Perdarahan uterus disfungsi
 - Perdarahan menoragia
 - Kista ovarium akut
 - Radang Pelvik akut
 - Abses Pelvik
 - Infeksi Saluran Genitalia
 - Skreening pelayanan HIV – AIDS
5. Perawatan Khusus / High Care Unit
6. Pelayanan Penunjang Medik
- a. Pelayanan darah
- Merencanakan kebutuhan darah di RS
 - Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pada pasien sebelum melakukan transfuse darah
 - Melakukan kerjasama dengan penyedia darah atau PMI setempat
- b. Perawatan Intensif
- Pemantauan terapi cairan
 - Pengawasan gawat nafas / ventilator
 - Perawatan sepsis
 - Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat, tunjangan kardio- respirasi jangka pendek dan mempunyai peran memantau serta mencegah penyulit pada pasien medik dan bedah



yang berisiko.

- Ventilasi mekanik dan pemantauan kardiovaskuler sederhana.
- Memiliki Dokter jaga 24 jam dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru.
- Dokter Spesialis Anestesiologi

c. Penunjang

- Radiologi
- USG/Ibu dan Neonatal

d. Laboratorium

- Pemeriksaan rutin darah, urin
- Kultur darah, urin, pus
- Kimia

BAB V TATA LAKSANA

5.1 Kriteria Pelayanan PONEK

- 1 Ada dokter jaga yang terlatih di IGD untuk mengatasi kasus emergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik – neonatal.
- 2 Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- 3 Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal.
- 4 Mempunyai standar respon time :
 - a. IGD selama 10 menit,
 - b. kamar bersalin kurang dari 30 menit,
 - c. pelayanan darah kurang dari 1 jam.
- 5 Tersedia kamar operasi siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum.
- 6 Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.
- 7 Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun *on call*.
- 8 Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat.
- 9 Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.
- 10 Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK seperti :
 - a. Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam,
 - b. recovery room 24 jam,
 - c. obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia.

5.2 Tata Laksana Pelayanan Kehamilan

Menurut departemen Kesehatan RI (2018), petugas kesehatan melakukan pelayanan kehamilan sesuai dengan standart pelayanan antenatal, diantaranya :

- a. Melakukan anamnesis secara lengkap yaitu :
 - 1) Riwayat kehamilan sekarang
 - 2) Riwayat obstetri masa lalu
 - 3) Riwayat penyakit
 - 4) Riwayat sosial ekonomi
- b. Melakukan pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan Fisik umum
 - 2) Pemeriksaan luar (abdomen)
 - 3) Pemeriksaan dalam bila diperlukan
 - 4) Pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik
- c. Melakukan assesment/diagnose
- d. Mengupayakan kehamilan yang sehat
 - 1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin
 - 2) Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan
 - 3) Ibu mengikuti kelas ibu
 - 4) Memberikan nutrisi yang adekuat



- e. Melakukan deteksi dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan serta melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
- f. Memberikan pelayanan/ asuhan standart minimal termasuk 10 T yaitu :
 - 1) Timbang berat Badan
 - 2) Ukur Tekanan darah
 - 3) Ukur Fundus uteri
 - 4) Pemberian imunisasi (tetanus Toksoid) TT Lengkap
 - 5) Pemberian Tablet Zat besi, minimal 90 tablet selama kehamilan
 - 6) Tetapkan status gizi (lila)
 - 7) Tes terhadap penyakit menular seksual
 - 8) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin
 - 9) Tatalaksana kasus
 - 10) Temu wicara dalam rangka persiapan rujuk
- g. Ibu hamil suami dan keluarga mengetahui tanda bahaya kehamilan dan mengetahui apa yang harus dilakukan
- h. Persiapan persalinan yang aman dan bersih
 - 1) Selalu melakukan personal hygiene
 - 2) Pakaian dala diganti minmal 2x sehari
 - 3) Merencanakan ertolongan persalinan ke sarana kesehatan
- i. Perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi
- j. Pelayanan antenatal dapat dilakukan penanganan pasien dengan
 - 1) Pelayanan pasien dengan abortus
 - 2) Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik (KE)
 - 3) Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik terganggu (KET)
 - 4) Penanganan pasien dengan hipertensi
 - 5) Penanganan pasien dengan preeklamsia/eklamsi
 - 6) Penanganan pasien dengan plasenta previa
 - 7) Penanganan pasien dengan solusio lasenta
 - 8) Penanganan pasien dengan rupture uteri
 - 9) Penanganan pasien dengan kehamilan metabolic

5.3 Tatalaksana Pelayanan Persalinan

Persalnan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamian cukup bulan (37- 42 Minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.

Pengkajian awal pada pelayanan persalinan adalah :

1. Melakukan anamnesis
Identitas asien, keuhan utama, riwayat persalinan, riwayat kebidanan, riwayat medik, riwayat sosial, riwayat kehamilan terdahuu, terahir kali makan atau inum, lama istirahat/tidur, melakukan screening covid-19 (riwayat demam,batuk,pilek dan riwaat kontak dengan kasus emergin dalam 2 minggu terahir).
2. Melakukan pemeriksaan fisik
Tanda-tanda vital, konjungtiva dan sklera, pemeriksian abdomen, tinggi fundus uteri,kontraksi uterus, denyut jantung janin, pemeriksaan CTG sesuai indikasi, pemeriksaan dalam, pemeriksaan edema dan varises pada tagan dan kaki
3. Membuat diagnosis
Diambil esimpulan dari hasil anamnese pasien dan hasil pemeriksaan fisik, gravida berapa, pernah partus berap kali dan pernah abortus berapa kali, parturin berapa minggu dan dalam kala berapa serta dalam vase apa, Misalnya G5P3003Ab1 UK 39 Minggu kala 1 fase laten
4. Membuat planing dan implementasi
 - a. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga



- b. Pemantauan/observasi tanda vital, His DJJ dan kemajuan persalinan, yaitu

Tabel 5 Pemantauan observasi persalinan

Kala I		TD	N	RR	S	His	Djj	VT	Pencatatan
Laten	Normal	4 jam	4 jam	4 jam	4 jam	1 jam	1 jam	4 jam	Lembar observasi
	Induksi	4 jam	4 jam	4 jam	4 jam	30 menit	30 menit	4 jam	Lembar observasi
Aktif	Normal	4 jam	30 menit	4 jam	2 jam	30 menit	30 menit	4 jam	partograf
	induksi	4 jam	30 menit	4 jam	2 jam	30 menit	30 menit	4 jam	partograf

- Kala I
 - 1) Berikan nutrisi dan idrasi pada ibu atau bisa dibantu oleh keluarga
 - 2) Berikan dukungan pada ibu dan keluarga
 - 3) Memastikan kembali partuset dan APD serta obat essensial siap pakai dan lengkap
 - 4) Memberikan informasi tentan Inisiasi Menyusui Dini dan Kontrasepsi
 - 5) Kolaborasi dengan dokter obgyn apabila tidak ada kemajuan persalinan dan partograf telah berada dalam garis bertindak.
- Kala II adalah kala persalinan dimana pembukaan sudah lengkap yang dilakukan bidan adalah :

Tabel 6 tindakan kala II

Kemajuan Persalinan	Kondisi Ibu pasien	Kondisi Jan
- Usaha mendedan - Palpasi kontraksi uterus (kontrol tiap 10 menit) Frekuensi, lama dan kekuatannya	- Periksa nadi dan tekanan darah tiap 30 menit - Respon keseluruhan pada kala II : g. Keadaan dehidrasi h. Perubahan sikap/prilaku i. Tingkat tenaga yang dimiliki	- Periksa FDJJ setiap 15 menit/ atau lebih sering dilakukan dengan semakin dekatnya kelahiran - Penurunan presentasi dan perubahan posisi - Warna tertentu cairan tertentu

- 1) Pada kala II dipimpin mendedan apabila Kepala jann sudah tampak di vulva vagina dengan diameter 5-6 cm depan vulva, apabila belum tampak di vulva maka ibu boleh mendedan dalamposisi miring atau senyaman ibu.
- 2) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu
- 3) Menjaga personal hygiene
- 4) Menyiapkan posisi ibu saat berair
- 5) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran dengan posisi setengah duduk
- 6) Menolong kelahiran dengan persaina yang bersih dan aman
- 7) Selama persalinan normal, intervensi hanya dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan. Prosedur ini hanya dibutuhkan jika ada infeksi atau penyulit
- 8) Melakukan inisiasi menyususi dini selama 1 jam bila APGAR score bayi bagus.



- Kala III
 - 1) Cek uterus untuk menentukan apakah ada bayi kedua, jika ada tunggu sampai bayi lahir
 - 2) Memberikan injeksi oksitosin 10 iu IM dalam waktu 1 menit. Apabila plasenta belum lahir setelah 15 menit maka dapat diuangi oksitosin 10 iu IM kedua
 - 3) Menjepit dan menggunting tali pusat
 - 4) Menilai apakah bayi baru lahir dalam keadaan stabil, jika tidak lakukan resusitasi segera dan apabila bayi langsung mnenagis maka lakukan inisiasi menyusui dini sela 1 jam
 - 5) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PPT)
 - 6) Masase fundus uteri
- Kala IV
 - 1) Periksa fundus, plasenta seaput ketuban, perinium, perdarahan, lochea, kandung kemih, kondisi ibu, kondisi bayi baru lahir
 - 2) Berikan nutrisi dan hidrasi
 - 3) Melanjutkan inisiasi menyusui dini (IMD) selam 1 jam
 - 4) Melakukan personal hygiene
 - 5) Dokumenasi dan dekomuntasi alat

5.4 Tata Laksana pelayanan Nifas

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berahir ketika kondisi kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 Minggu. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan fisiologis yaitu :

1. Perubahan fisik
2. Involusi uterus dan pengeluaran lochea
3. Laktasi/pengeluaran air susu ibu
4. Perubahan sistem tubuh lainnya
5. Perubahan psikis pemeriksaan pada ibu nifas
6. Pelayanan masa post natal dapat melakukan pelayanan pasien dengan :
 - a. Masa nifas
 - b. Demam pasca persalinan
 - c. Perdarahan pasca persalinan
 - d. Nyeri perut pasca persalinan
 - e. Keluarga berencana

5.5 Tata Laksana Rawat Gabung

Adalah suatu kegiatan yang membiarkan ibu dan bayi bersama terus menerus selama di rumah sakit. Rawat Gaun merupakan pilihan terbaik untuk merawat bayi dan ibu yang sehat karena dapat meningkatkan pemberian ASI, mengurangi resiko infeksi, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Rawat gabung dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Rawat gabung penuh Sistem perawatan ibu dan bayi bersama secara terus menerus selama 24 jam
2. Rawat Gabung parsial Suatu sistem perawatan ibu dan bayi hanya beberapa jam seharinya.

5.6 Tata Laksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

1. Definisi Inisiasi Menyusui Dini(IMD) adalah permulaan kegiatan menyusui dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui satu jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri dengan kata lain menyusui bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan The Breast Crawl atau merangkak mencari

payudara (Maryunani, 2012).

Inisiasi Menyusui Dini adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya, bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu, sampai bayi menyusui sendiri (Depkes, 2008)

2. Prinsip inisiasi menyusui dini (IMD) Inisiasi Menyusui Dini adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu, sampai dia menyusui sendiri. (Depkes, 2014)

Prinsip dasar IMD adalah tanpa harus dibersihkan dulu, bayi diletakkan di dada ibunya dengan posisi tengkurap dimana telinga dan tangan bayi berada dalam satu garis sehingga terjadi kontak kulit dan secara alami bayi mencari payudara ibu dan mulai menyusui. (Rosita, 2008) Kesimpulan dari pendapat di atas, prinsip IMD adalah cukup mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir dengan kain atau handuk tanpa harus memandikan, tidak membungkus (bedong) kemudian meletakkannya ke dada ibu dalam keadaan tengkurap sehingga ada kontak kulit dengan ibu, selanjutnya beri kesempatan bayi untuk menyusui sendiri pada ibu pada satu jam pertama kelahiran

3. Manfaat Inisiasi Menyusui Dini Menurut Roesli (2008), menyampaikan bahwa IMD bermanfaat bagi ibu dan bayi baik secara fisiologis maupun psikologis, yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu Sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitoksin. Oksitoksin menyebabkan kontraksi pada uterus sehingga membantu keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan. Oksitoksin juga menstimulasi hormon-hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman, sehingga ASI keluar dengan lancar
- b. Bayi Bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Bayi memperoleh kolostrom yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama. Di samping itu, kolostrom juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu usus bayi berfungsi secara efektif, sehingga mikroorganisme dan penyebab alergi lain lebih sulit masuk ke dalam tubuh bayi
- c. Manfaat secara Psikologis :
 - 1) Adanya Ikatan Emosi (Emotional Bonding) :
 - j. Hubungan ibu-bayi lebih erat dan penuh kasih sayang.
 - k. Ibu merasa lebih bahagia.
 - l. Bayi lebih jarang menangis.
 - m. Ibu berperilaku lebih peka (affectionately).
 - n. Lebih jarang menyiksa bayi (child abused).
 - 2) Perkembangan : anak menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari

4. Tata Laksana IMD

Menurut Depkes (2009), dalam buku pedoman pelaksanaan program rumah sakit sayang ibu dan anak, tatalaksana IMD yaitu:

- 1) Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan.
- 2) Disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat kimiawi saat persalinan. Dapat diganti dengan cara non kimiawi, misalnya pijat, aroma therapy atau gerakan.
- 3) Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya melahirkan normal, didalam air atau dengan jongkok.
- 4) Keringkan bayi secepatnya, kecuali kedua tangannya. Pertahankan



lemak putih alami (vernix) yang melindungi kulit baru bayi.

- 5) Bayi di tengkurapkan didada atau perut ibu. Biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum satu jam atau setelah menyusui awal selesai. Keduanya diselimuti, jika perlu gunakan topi bayi.
- 6) Biarkan bayi mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu.
- 7) Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusui.
- 8) Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit pada ibu yang melahirkan dengan tindakan, misalnya operasi sectio caesarea.
- 9) Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur dan dicap setelah satu jam atau menyusui awal selesai. Prosedur yang invasif misalnya suntikan vitamin K dan tetesan mata bayi dapat ditunda.
- 10) Rawat gabung-ibu dan bayi dirawat satu kamar selama 24 jam, bayi tetap tidak dipisahkan dan bayi selalu dalam jangkauan ibu. Pemberian minuman prelaktal (cairan yang diberikan sebelum ASI keluar) dihindarkan.

Depkes (2009) juga menjelaskan tatalaksana IMD pada persalinan sectio caesarea, yaitu :

- a. Tenaga dan pelayanan kesehatan yang suportif.
- b. Jika mungkin, diusahakan suhu ruangan 20°-25°
- c. Disediakan selimut untuk menutupi punggung bayi untuk mengurangi hilangnya panas dari kepala bayi.
- d. Usahakan pembiusan ibu bukan pembiusan umum tetapi epidural.
- e. Tatalaksana selanjutnya sama dengan tatalaksana umum diatas.
- f. Jika inisiasi dini belum terjadi dikamar bersalin, kamar operasi, atau bayi harus dipindah sebelum satu jam maka bayi tetap diletakan didada ibu ketika dipindahkan ke kamar perawatan atau pemulihan. Menyusui dini dilanjutkan di kamar perawatan ibu atau kamar pulih.

5. Faktor-faktor yang menghambat IMD

Maryunani (2012) menjelaskan, ada faktor-faktor yang dapat menghambat IMD baik pada persalinan normal maupun pada persalinan sectio caesarea.

- a. Faktor-faktor yang menghambat IMD pada persalinan normal, yaitu :
 - 1) Pada persalinan normal, diharapkan agar setiap ibu dapat mencapai keberhasilan, mampu melaksanakan program IMD tidak lebih dari satu jam.
 - 2) Namun pada kenyataannya, ada beberapa ibu yang mengeluhkan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan IMD.
 - 3) Beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan program IMD pada pasien dengan persalinan normal tersebut, antara lain :
 - a) Kondisi ibu yang masih lemah (bagi ibu post-partum normal, dalam kondisi kelemahan ini, ibu tidak mampu untuk melakukan program IMD).
 - b) Ibu lebih cenderung suka untuk beristirahat saja dari pada harus kesulitan membantu membimbing anaknya untuk berhasil melakukan program IMD.
- b. Faktor-faktor yang menghambat IMD pada persalinan sectio caesarea, yaitu :
 - 1) Rooming-in (Rawat Gabung)
 - 2) Kondisi sayatan di perut ibu. Pada pasien caesar, dimana terdapat sayatan di perut, ibu cenderung masih mengeluhkan sakit pada daerah sayatan dan jahitan di perut, sehingga ibu memilih untuk istirahat, dahulu, dan memulihkan kondisinya yang lemas sebelum



memberikan IMD pada bayinya. Oleh karena itu, maka pada pasien dengan persalinan caesar, ibu baru bisa berhasil memberikan ASI pertamanya kepada bayi setelah lebih dari satu jam pasca melahirkan.

- 3) Kondisi kelemahan akibat pengaruh anestesi yang diberikan sebelumnya.

5.7 Tata Laksana Pelayanan Metode Kangguru (PMK) pada Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)

1. Pengertian

Perawatan metode kangguru merupakan alternatif metode perawatan bayi barulahir. Metode ini adalah salah satu teknik yang tepat dan sederhana, serta murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan pada bayi BBLR. Metode ini tidak hanya menggantikan inkubator, tetapi juga dapat memberikan manfaat lebih yang tidak didapat dari pemberian inkubator. Pemberian metode kangguru ini dirasa sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang sangat mendasar seperti kehangatan, air susu ibu, perlindungan dari infeksi, stimulasi, keselamatan dan kasih sayang (Maryunani, 2013).

2. Jenis Perawatan Metode Kangguru Pemberian metode kangguru terdapat dua jenis, perawatan metode kangguru intermitten dan kontinyu:

- a. Perawatan Metode Kangguru Intermitten Metode ini biasanya dilakukan pada fasilitas unit perawatan khusus dan intensif. Metode ini tidak diberikan secara terus menerus sepanjang waktu, hanya diberikan ketika ibu mengunjungi bayi yang masih berada dalam inkubator dengan durasi minimal satu jam secara terus menerus dalam satu hari. Metode ini dapat dimulai pada bayi yang sakit, yang berada dalam proses penyembuhan tetapi masih memerlukan pengobatan medis (seperti infus, tambahan oksigen dengan konsentrasi rendah) (Maryunani, 2013)
- b. Perawatan Metode Kangguru Kontinyu Metode kontinyu ini bisa dilakukan di unit rawat gabung atau ruangan yang diperuntukan untuk perawatan kangguru ataupun dilakukan di rumah. Pada metode kontinyu ini dapat dilakukan sepanjang waktu. Perawatan kontinyu dapat diterapkan apabila kondisi bayi dalam kondisi stabil yakni bayi dapat bernafas secara alami atau spontan tanpa oksigen bantuan (Maryunani, 2013).

3. Lama dan jangka waktu penerapan PMK

- a. Secara bertahap lama waktu penerapan metode kangguru ditingkatkan dari:
 - 1) Mulai dari perawatan belum menggunakan perawatan metode kangguru
 - 2) Dilanjutkan dengan pemberian perawatan metode kangguru intermitten
 - 3) Kemudian diikuti dengan perawatan metode kangguru kontinyu (Maryunani, 2013)
- b. Pelaksanaan metode kangguru yang singkat kurang dari 60 menit dapat membuat bayi stress. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut antara lain:
 - 1) Jika bayi masih berada di fasilitas pelayanan kesehatan, maka lebih baik bayi diletakkan di inkubator.
 - 2) Apabila bayi telah dilakukan pemulangan, anggota keluarga lain dapat menggantikan ibu dalam melaksanakan perawatan metode kangguru (Maryunani, 2013)
 - 3) Pemberian metode kangguru dapat dihentikan, apabila :
 - a) Berat badan bayi minimal >2500 gram
 - b) Bayi mampu menetek dengan kuat seperti bayi besar dan sehat
 - c) Suhu tubuh bayi stabil 37°C (Maryunani, 2013)



4. Tujuan Perawatan Metode Kangguru Tujuan dari pemberian metode kangaroo mother care adalah untuk menjaga agar bayi tetap hangat. Metode ini dapat dimulai segera setelah bayi lahir atau setelah bayi stabil. Metode ini dapat dilakukan di rumah sakit maupun di rumah. Pemberian metode ini dapat terus dilakukan meskipun bayi belum bisa menyusui (Sudarti, Endang Khoirunnisa., 2010).
5. Pelaksanaan Perawatan Metode Kangguru
 - a. Pelaksanaan metode kangguru adalah skin to skin atau kulit dengan kulit antara bagian depan tubuh bayi dengan dada dan perut ibu dalam baju kangguru. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Semua pakaian bayi dilepas
 - b. Ibu atau keluarga yang akan menggendong diminta melepas BH atau baju dalam (hanya memakai baju/atau kaos yang longgar)
 - c. Gendong bayi, letakkan bayi didalam baju sehingga terjadi sentuhan kulit ibu dan kulit bayi tanpa perantara
 - d. Bebat/ikat pinggang ibu dibawah badan bayi sehingga badan badan bayi terhatan tidak turun (ikatan di luar baju)
 - e. Gendong bayi seperti biasa menggunakan kain, ikatan kain penggondongdiluar baju ibu
 - f. Pakaikan topi penutup kepala bayi (Ari Sulistyawati, 2009)

5.8 Tata Laksana Neonatal Fisologis

a. Asuhan Bayi baru lahir

Tujuan utama perawatan bayi segera setekah lahir adalah :

1. Membersihkan jalan nafas
2. Memotong jalan nafas
3. Memertahankan suhu tubuh bayi
4. Identifikasi
5. Pencegahan infeksi
6. Pemantauan bayi baru lahir :
 - a. Kemampuan menghisap kuat atau lemah
 - b. Bayi tampak aktif atau lunglai
 - c. Bayi kemerahan atau biru
 - d. Bayi kecil untuk masa kehamilan atau bayi kurang bulan
 - e. Gangguan pernafasan
 - f. Hipotermia
 - g. Infeksi
 - h. Cacat bawaan dan trauma lahir
7. Pemeriksaan pada bayi baru lahir :
 - a. Pernafasan (normal, mendengkur, hidung mengembang, penarikan Kembali tersengal atau tidak
 - b. Berat badan dan panjang badan
 - c. Suhu badan
 - d. Refleks (menghisap, rooting, menggenggam)
 - e. Warna kulit (kemerahan, biru, pucat, kuning)
 - f. Keadaan mata (jernih, berair, kuning)
 - g. Keadaan talipusat (kering, mengeluarkan darah atau tidak)
 - h. Kelainan (bibir/langit-langit sumbing, anus tidak berlubang
8. Pelayanan kesehatan neonatal dapat melakukan pelayanan pasien dengan :
 - a. Hiperbilirubin
 - b. Asfixia
 - c. Trauma kelahiran



- d. Hipoglikemi
- e. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit
- f. Gangguan pernafasan
- g. Pemberian cairan parenteral
- h. Aspirasi meconial
- i. Inisiasi dini ASI (Breast Feeding)
- j. Kanggoro Mother Cara (PMK)
- b. Imunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang
 - 1. Layanan imunisasi untuk HB 0 dilakukan di ruang neonatologi
 - 2. Imunisasi selanjutnya dilakukan di poli Anak meliputi program imunisasi wajib dan imunisasi yang dianjurkan
 - 3. Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang dilakukan dipoli Anak oleh dokter Spesialis anak.
- 5.9 Tata Laksana Pelayanan High Care Unit
 - 1. Penanganan pada pasien eklamsia
 - 2. Penanganan pada pasien perdarahan ante partum
 - 3. Penanganan pada pasien perdarahan post partum
 - 4. Penanganan pada pasien pre eklamsia berat
 - 5. Penanganan pada pasien Syok
 - 6. Penanganan pada pasien emergency
- 5.10 Tata laksana pelayanan kesehatan neonatal
 - 1. Hiperbilirubinemia
 - 2. Asfiksia
 - 3. Trauma kelahiran
 - 4. Hipoglikemi
 - 5. Kejang/ sepsis neonatal
 - 6. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit
 - 7. Gangguan ernafasan
 - 8. Gangguan perdarahan
 - 9. Syok
 - 10. Aspirasi meconium
 - 11. Inisiasi dini ASI (Breast Feeding)
 - 12. Kanggoroo Mother Care (PMK)
 - 13. Resusitasi neonates
 - 14. Pemberian minum pada bayi resiko tinggi
 - 15. Ibu dengan kasus emergency
- 5.11 Tata laksana pelayanan Ginekologi
 - 2. Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik
 - 3. Penanganan pasien dengan kista ovarium
 - 4. Penanganan pasien dengan Infeksi saluran genitalia
 - 5. Penanganan pasien dengan radang pelvis akut
 - 6. Penanganan pasien dengan endometriosis
 - 7. Penanganan pasien dengan perdarahan uterus disfungsi
 - 8. Penanganan pasien dengan perdarahan menoragi
- 5.12 Tata laksana pelayanan kamar operasi
 - 1. Sectio caesaria
 - 2. Perbaikan robekan dinding uterus
 - 3. Reposisi inversio uteri
 - 4. Histerectomy
 - 5. Anestesi umum dan spinal untuk SC
- 5.13 Sistem Rujukan.
 - 2.3.1 Pengertian Rujukan

Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun



horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:

1. Rujukan Pasien Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit. Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada
2. Rujukan Manajemen Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.
2. Sistem pelayanan rujukan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada

Bila pasien maternal dan perinatal tidak dapat ditangani sendiri segera rujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap fasilitas dan tenaga kesehatannya. Harus ada koordinasi, mudah sehingga tidak merugikan pasien. Mudah, cepat dan tepat adalah yang utama.

Rujukan internal rumah sakit berpedoman kepada prosedur rujukan di dalam rumah sakit dan mekanisme kerja di bagian /instalasi Anak, Obstetri, dan Ginekologi. Rujukan eksternal mengikuti mekanisme rujukan sesuai jenjang pelayanan. Melakukan Persiapan Rujukan Pasien ke jenjang pelayanan yang lebih tinggi yaitu

- b. Menyiapkan petugas yang terlatih untuk mendampingi pasien
- c. Memberi penjelasan kepada pihak keluarga alasan pasien di rujuk ke rumah sakit lain.
- d. Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
- e. bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- f. Pada saat merujuk pasien harus disertakan surat rujukan dan resume medik pasien meliputi: riwayat penyakit, penilaian kondisi pasien yang dibuat saat kasus diterima perujuk, tindakan atau pengobatan yang telah diberikan dan keterangan lain yang perlu atau ditemukan sehubungan dengan kondisi pasien.
- g. Proses pelaksanaan rujukan harus mendapat persetujuan dari dokter dan keluarga

Rumah Sakit sebagai penerima rujukan yaitu :

1. Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
 2. Bahwa segala tindakan yang dilakukan Adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya
 3. Persiapan pihak keluarga untuk memberikan darah jika dibutuhkan
 4. Pasien/keluarga diberi penjelasan mengenai Tindakan/perawatan yang akan dilaksanakan
3. Program pembinaan Jejaring Rujukan di rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Dalam upaya mencapai tujuan tercapainya Pembinaan Jejaring diperlukan peran petugas kesehatan dan fasilitator, dimana petugas kesehatan memberikan pembinaan dan fasilitator bertanggungjawab melakukan hal-hal yang sudah disampaikan oleh petugas kesehatan dari rumah sakit Prima Husada.

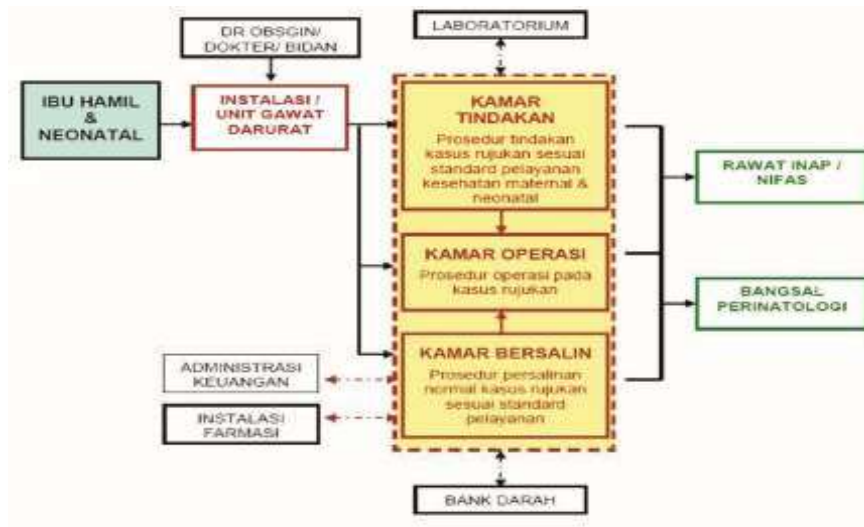
Adapun Program pembinaan jejaring Rujukan rumah sakit antara lain :

- b. Pelatihan kepada fasilitas Kesehatan jejaring yang dilakukan oleh dokter spesialis rumah sakit .
- c. Berbagi pengalaman dalam pelayanan ibu dan anak bertujuan untuk tukar pendapat dan bisa memperbaiki penanganan yang kurang

tepat menjadi tepat dan aman untuk pasien.

- d. Peningkatan kompetensi jejaring rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit Prima Husada supaya pasien yang rencana dirujuk dapat penanganan yang tepat dan aman sampai tujuan

Berikut Alur masuk pasien PONEK





BAB VI

PENERAPAN PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

6.1 Pengertian

Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, umum dan khusus yang telah melaksanakan 10 Langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.

6.2 Tujuan

1. Umum :
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara terpadu dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Khusus :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
 - c. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neontatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)
 - d. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
 - e. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif
 - f. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR.
 - g. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB

6.3 SASARAN

Ibu nifas dan bayi baru lahir di rumah sakit prima husada

6.4 STRATEGI PELAKSANAAN

Melaksanakan Perlindungan Ibu dan Bayi secara terpadu dan paripurna melalui 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

1. Ada kebijakan tertulis tentang manajemen yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk pemberian ASI eksklusif dan Perawatan Metode Kangguru (PMK) untuk bayi Berat Badan Lahir Rendah.
2. Menyelenggarakan pelayanan antenatal termasuk konseling kesehatan maternal dan neonatal
3. Menyelenggarakan persalinan bersih dan aman serta penanganan pada bayi baru lahir dengan Inisiasi menyusui dini dan kontak kulit ibu-bayi di kamar bersalin untuk persalinan normal dan di lakukan di kamar operasi untuk pasien post SC
4. Menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)



-
5. Menyelenggarakan pelayanan adekuat untuk nifas, rawat gabung termasuk membantu ibu menyusui yang benar, dan pelayanan neonatus sakit
 6. Menyelenggarakan pelayanan rujukan dua arah dan membina jejaring rujukan pelayanan ibu dan bayi dengan sarana kesehatan lain.
 7. Menyelenggarakan pelayanan imunisasi bayi dan tumbuh kembang
 8. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi lainnya
 9. Menyelenggarakan Audit Maternal dan Perinatal Rumah Sakit secara periodik dan tindak lanjut
 10. Memberdayakan Kelompok pendukung ASI dalam menindaklanjuti pemberian ASI eksklusif dan PMK



BAB VII LOGISTIK

7.1 SARANA DAN PRASARANA

Tabel 7 Sarana dan Prasarana (Logistik)

1	POLIKLINIK	4	KAMAR BERSALIN
	1. USG 2. Lampu sorot 3. Kulkas 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Metelin 7. Patella hammer 8. Timbangan 9. Senter 10. Bak instrumen : pinset chirurgi dan anatomis , gunting AJ , speculum , tenakulum , tampon tang , sonde , crocodile 11. Timbangan bayi manual dan digital 12. Pengukur tinggi badan 13. Sudip lidah		1. Vakum 2. Resusitasi bayi 3. Resusitasi ibu 4. Partus Set 5. Curretage set 6. IUD set 7. Heacting set 8. Lampu sorot 9. Senter 10. Doppler / Funandoskop 11. Metelin 12. Timbangan dewasa dan bayi 13. Dipstik 14. Tensi meter 15. Termometer 16. Infus set 17. NST 18. Suction 19. Usg transport 20. Infant warmer
2	IGD PONEK	5	RUANG NIFAS
	1. Instrumen tindakan 2 set (partus set) 2. Resusitasi ibu dan bayi 3. Lampu sorot 4. Infus pump 5. Syringe pump 6. Infant warmer 7. Suction		1. Infus pump 2. Syringe pump 3. Tensi meter 4. Termometer 5. Box bayi 6. Cuvis
3	KAMAR OPERASI	6	RUANGAN PERINATOLOGY – NICU
	Instrumen operasi minimal 2 set (dipersiapkan untuk curret suction , SC , laparatomi)		1. Incubator 2. CPAP 3. Incubator transport 4. Infus pump 5. Syringe Pump



			6. Foto terapy 7. Resusitasi bayi 8. Saturasi bayi 9. Thermometer 10. Kulkas 11. Baby table
7	RUANGAN LAINNYA		
	1. Ruang laktasi 2. Ruang senam hamil		



BAB VIII KESELAMATAN PASIEN

8.1 Pengertian

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Keselamatan pasien di ruang rawat inap merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mengingat perawatan pada pasien rawat inap membutuhkan perhatian yang lebih dan membutuhkan penanganan jangka panjang yang perlu keseriusan dari tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan penanganan dalam praktiknya. Kejadian yang mengacu pada keselamatan pasien diantaranya pasien terjatuh dari tempat tidur, pasien diberi obat salah, tidak ada obat/alat emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada alat penyedot lendir, tidak tersedia alat pemadam kebakaran, dan pemakaian obat.

8.2 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di RS
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan

8.3 Stadar Kesehatan Pasien

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasive
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan Kesehatan
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

8.4 Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan

Kesalahan dalam sasaran keselamatan pasien bisa menyebabkan kefatalan dalam pelayanan, yaitu bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contoh dalam hal ini adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pada saat sebelum melakukan Tindakan, identifikasi tidak dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).

8.5 Tata Laksana

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar

- a. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien
- b. Gelang identitas untuk pasien laki-laki berwarna biru muda dan gelang identitas untuk perempuan berwarna merah muda. Bila pasien ada resiko jatuh diberi stiker warna kuning dan bila pasien ada alergi diberi stiker warna merah di gelang identitas pasien
- c. Ada dua identitas yang digunakan yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan tanda pengenalan resmi.
- d. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum :



- 1) Melakukan tindakan/ intervensi/ terapi (misalnya pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, melakukan terapi radiasi).
 - 2) Melakukan tindakan (misalnya memasang jalur intravena atau hemodialisa)
 - 3) Sebelum tindakan diagnostic apa pun (misalnya mengambil darah dan specimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan keterisasi jantung ataupun Tindakan radiologi diagnostic)
 - 4) Menyajikan makanan pasien
 - 5) Staf unit pelayanan
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
- a. Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap
 - b. Metode komunikasi saat menerima intruksi melalui telepon adalah : menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (writedown, read back, confirmation)
 - c. Saat melaporkan metode yang digunakan adalah Situation – Background – Assessment – Recommendation (SBAR)
 - d. Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostic melalui telpon juga dengan menggunakan menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (writedown, read back, confirmation)
 - e. Metode komunikasi saat serah terima antar ruangan dan atau di salam ruangan menggunakan formulir khusus
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
- a. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat kimia yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya
 - b. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (nama obat rupa dan ucapan mirip/ NORUM, atau LASA(look alike sound alike))
 - c. Elektrolit konsentrat yang melebihi 50%, contoh : KCL 3%, NS 3%.
 - d. Ada protocol dalam pemberian terapi dalam menanggulangi hypokalemia, hyponatremia, dan hipofastemia yang sudah tertera dalam PPK (panduan praktek klinis)
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasive
- a. Tindakan operasi dan invasive meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasiperkutan, injeksi obat tertentu, biopsy, tindakan intervensi atau diagnostic vaskuler dan kardiak perkutan, laparaskopi, ekstraksi gigi, ESWL, danendoskopi.
 - b. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien
 - c. Penandaan lokasi tindakan operasi/ invasive dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut
 - d. PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/ invasive dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung
 - e. Pada tindakan operasi, dokter operator/ dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bedah akan melakukan tindakan penandaan Lokasi
 - f. Tindakan invasive non-operasi, penandaan dilakukan oleh dokter yang akan melakukan Tindakan
 - g. Penandaan dapat dilakukan di area luar kamar operasi
 - h. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali yaitu dengan tanda lingkaran dan panah pada area yang akan dilakukan Tindakan
 - i. Tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan
 - j. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau



multiple level (tulang belakang)

5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :
 - a. Sebelum kontak langsung dengan pasien
 - b. Setelah kontak langsung dengan pasien.
 - c. Sebelum melakukan tindakan invasif pada pasien.
 - d. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
 - e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien
- 6 langkah cuci tangan menggunakan handwash sebagai berikut :
 - a) Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengalir ke tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
 - b) Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
 - c) Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
 - d) Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
 - e) Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
 - f) Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
 - g) Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
 - h) Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
 - i) Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh
 - a. Pengkajian risiko jatuh pada semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak dilakukan sesuai regulasi Panduan Upaya Mengurangi Cedera Pasien Akibat Jatuh b
 - b. Pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap dilakukan pada saat terjadi perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian
 - c. Tindakan dan/ atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan



BAB IX KESELAMATAN KERJA

9.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan 48system48an sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari 48system manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

9.2 Pengertian

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

9.3 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

9.4 Tata Laksana Keselamatan Kerja

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

1. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
2. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
3. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum atau pun spuit bekas.
4. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
5. Setiap pasien yang menular atau beresiko menular di rawat di ruang isolasi.
6. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
 - b. Menggunakan alat pelindung (hazmat/ skort, sarung tangan, kaca mata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker, dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll



- c. Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misal : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
- d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.
7. Terdapat tempat sampah infeksius dan noninfeksius.
8. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
9. Menggunakan baju kerja yang bersih

9.5 Prinsip Keselamatan Kerja

Dalam prinsip kesehatan keselamatan kerja (K3) secara utuh di rumah sakit ada 3 komponen penting yang saling berhubungan, antara lain :

1. Kapasitas kerja, kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
2. Beban kerja, suatu kondisi yang membebani pekerja baik secara fisik maupun non fisik dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non fisik.
3. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.



BAB X PENGENDALIAN MUTU

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, pelayanan rawat inap harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu. Dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan PONEK perlu ada suatu program yang terencana dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi pelayanan PONEK dalam mengevaluasi dan membuat rencana tindak lanjut sehingga tercapai peningkatan mutu pelayanan yang diharapkan. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan Indikator PMKP

Mutu dari pelayanan PONEK meliputi :

Tabel 10.1 Mutu pelayanan Ponek

No	Indikator	Standart
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100 %
2	Angka keterlambatan operasi SC Cito > 30 menit	0%
3	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	0%
4	Angka kematian bayi	0%
5	Angka kematian ibu	0%
6	Kejadian tidak dilakukanya IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir	0
7	Kejadian perdarahan post partum	0
8	Kejadian partus lama	0
9	Kejadian eklamsi	0
10	Kejadian Pre eklamsi	0
11	Kejadian Infeksi Nifas	0



BAB XI PENUTUP

Perawatan perinatal tidak dapat dipisahkan dengan riwayat kehamilan seorang ibu, sedangkan angka kematian maternal sendiri masih sangat tinggi yang banyak disebabkan karena perdarahan, infeksi dan hipertensi. Oleh sebab itu peningkatan kualitas dari pelayanan obstetric dari pusat rujukan adalah sangat penting. Rumah Sakit Prima Husada sebagai tempat pelayanan yang terkait secara khusus dalam pelayanan perinatal resiko tinggi berperan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dalam keikutsertaan untuk menurunkan angka kematian maternal neonatal.

Telah disusun suatu Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagai acuan untuk melaksanakan dan mengelola pelayanan kesehatan maternal neonatal di ruang lingkup Rumah Sakit Prima Husada.

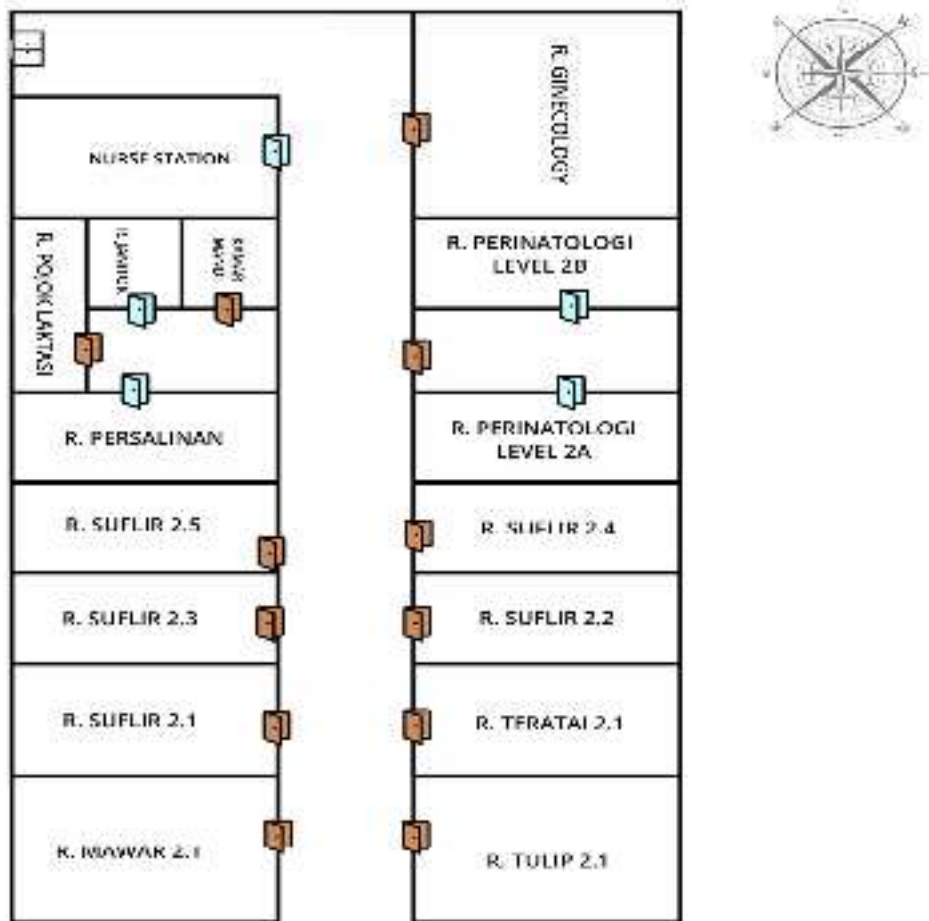
Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep



LAMPIRAN 1



DENAH RUANG MATERNITAS



LAMPIRAN 2

LAYOUT IGD RSPHS

